

Fecha Última Actualización: 11-03-2022 16:59:30

Página 1 de 3

### Información Paciente

**Nombre** : Diego Orlando Muñoz Chihuaipan  
**Edad** : 30a 2m 17d  
**Dirección** : San Pedro 424

**Rut** : 18.074.165-8  
**Fecha Nacto**: 22/12/1991  
**Comuna** : Puente Alto

**N° Archivo** : A655149  
**Sexo** : Masculino  
**Teléfono** : 9 5773 0792

**N° Epicrisis**  
**299054**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Upc - Uci Adulto  
**Unidad de Egreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Ingreso** : 17/02/2022 09:21  
**Fecha Egreso** : 11/03/2022 16:03

**Días Estadía**: 22

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abdominal

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

AM: Discapacidad intelectual moderada, Tumor testicular con MTT a pulmón y retroperitoneo de reciente diagnóstico. Hospitalización reciente 07/02 al 11/02 para orquiectomía.

Alergias: (-)

Qx: Cirugía costal en la infancia, orquiectomía radical derecha 08/02/22

Paciente con antecedentes descritos, con reciente diagnóstico de Tumor de Celulas Germinales con rpimario testicular y compromiso metastásico retroperitoneal con extensa masa y compromiso nodular pulmonar. Hospitalizado recientemente para orquiectomía radical derecha y biopsia, además de instalación de JJ derecho por HUN ipsilateral, es dado de alta el 11/02.

Posterior al alta, paciente evoluciona con náuseas y dolor abdominal, consulta al SU el 16/02, se toma TAC AP que muestra masa retroperitoneal tumoral de carácter secundario, asociado a gran hematoma adyacente, moderado hemoperitoneo y signos de pancreatitis aguda, sin evidencia de sangrado activo. Requirió reanimación con 1 UGR. Evaluado por urología, sin posibilidad de resolución quirúrgica, inicialmente se planteó angioembolización por equipo de radiología intervencional e inicio precoz de QT.

Durante estadía en SU evoluciona febril, con compromiso de consciencia y mala mecánica ventilatoria, con estudio de laboratorio inicial compatible con FOM: insuficiencia renal, insuficiencia hepática, disfunción circulatoria y respiratoria. Se reanima, se conecta a VMI, se pancultiva y se inicia terapia ATB empírica. Se toma nuevo TAC TAP, compatible con focos de condensación pulmonares bilaterales, sugerentes de atelectasias, compromiso hemorrágico por lesiones pulmonares y posible compromiso infeccioso. Se traslada a UPC, donde ingresa en malas condiciones, taquicárdico, febril e hipotenso con requerimientos altos de DVA. Se inidica sedación profunda, BNM, PP, reanimación por metas, se instala CHD y se escala terapia ATB.

Diagnósticos de ingreso

- 1.Shock distributivo obs séptico
- 2.Insuficiencia respiratoria aguda grave con requerimiento de BNM y pronó
- 3.Falla renal aguda KDIGO 2
- 4.Hiperbilirrubinemia predominio directo y prolongación de INR, obs falla hepática aguda
- 5.Antecedentes

Evolución por planes

**Fecha Epicrisis** : 11/03/2022 16:59

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 11-03-2022 16:59:30

Página 2 de 3

HDN/CV: Inicialmente con requerimientos muy altos de DVA en contexto de shock séptico, tras estabilización inicial logra descenso y eventual suspensión de DVA. Evoluciona estable hasta el 07/03 donde nuevamente incia con requerimientos de DVA en altas dosis asociado a caída de Hb, con ecoscopia que muestra aumento de líquido libre abdominal, se interpreta como shock hemorrágico en contexto de hematoma retroperitoneal. Politransfundido durante estadía en UPC.

Respiratorio: A su ingreso cursó IRA por shock séptico, requirió PP y BNM hasta el 22/02. Evoluciona favorablemente desde un punto de vista ventilatorio, con PaFi en ascenso progresivo, se mantiene en ventilación protectora en contexto de conflictos infecciosos y hemodinámicos.

Renal: Desde su ingreso cursando AKI KDIGO III oligoanúrica, probable NTA, con requerimientos de HD desde el 22/02 los cuales no logra suspender, llegando a requerir HD continua en contexto de administración de QT. En contexto de deterioro hemodinámico y mala tolerancia a procedimiento se decide suspensión de HD el 11/03

Infeccioso: Múltiples hits

- Al ingreso con sepsis de foco respiratorio, inicialmente cubierto con Imipenem/Vancomicina, en CAET se aísla ACBA resistente a Unasyn, por lo que se rota a colistin, el cual mantiene hasta la fecha.

- Febril persistente, HC 28/02 y 02/03 (+) para levaduras, además colonización multifocal por C. Albicans (vía aérea). Inicialmente cubierto con fluconazol, se cambia a Anidulanfungina el 04/03 tras confirmarse candidemia. HC de control (+) 1/2 para S. Epidermidis a las 48 horas, impresiona colonización. Evaluado por oftalmólogo, impresiona coriorretinitis por candida, se indica Moxifloxacino/Cloranfenicol oftálmico y se cambio Anidulanfungina por Fluconazol por mayor llegada a ojo.

- Por abundantes secreciones se tomo CAET el 02/ 03, (+) para ACBA y K. Oxytoca, se agrego cobertura con Imipenem

Evoluciona febril persistente, con PI estacionarios.

Urología/oncología: En seguimiento por urología y oncología dado Tumor Testicular de Celulas Germinales con MTT pulmonar y retroperitoneal, con biopsia compatible con Tumor Mixto No Seminoma. Operado con orquidectomía radical el 08/02. Discutido con oncología, en contexto de mayor estabilidad desde el punto de vista séptico se decide iniciar QT EP el 03/03, plan de 5 dosis. Posterior a 4ta dosis evoluciona con aplasia medular significativa y compromiso hemodinámico atribuido a sangrado retroperitoneal, en ese contexto se decide no administrar 5ta dosis. Evoluciona con mayor profundización de aplasia, se inicia Filgastrim, sin mayor respuesta.

Hepático/Gl: Cursando con ileo médico y hepatitis aguda en contexto de shock, con BiliT y transaminasas en franca elevación, además de prolongación de INR.

Nutricional: Inicialmente con NE, por mala tolerancia en contexto de ileo se inició el 02/03 NPTC, suspendida por hipertrigliceridemia, reiniciada el 06/03. Se suspendió nuevamente el 08/03 en contexto de inestabilidad hemodinámica.

Vascular: Con trombosis de la VCI, evaluado pr Cx vascular, sin indicación de FVCI dado alto riesgo de embolización durante procedimiento. Se mantiene sin anticoagulación durante hospitalización por riesgo de sangrado retroperitoneal.

En suma, paciente con shock hemorrágico en contexto de metástasis sangrante, requerimientos muy altos de DVA, sin posibilidad de resolución quirúrgica. Además cursando candidiasis invasora en contexto de aplasia medular tras QT. Pronostico reservado, se explica a familiares y se da aviso para acompañamiento. Paciente evoluciona con mayor inestabilidad hemodinámica, finalmente fallece el 11/03 a las 14 hrs

### Diagnóstico de Egreso

TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Se traslada a anatomía patológica

### Plan Post Alta

Se entregacertificado de defunción a la familia

### Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

### Controles

Fecha Epicrisis : 11/03/2022 16:59

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:24

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



# Epicrisis Hospitalaria

**ESTADO: DEFINITIVA**

Fecha Última Actualización: 11-03-2022 16:59:30



COMPLEJO ASISTENCIAL

**DR. SÓTERO DEL RÍO**

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Página 3 de 3

Maria Celis Le Roy

**Médico Tratante (Staff)**

**INTERNO**

**Becado/Residente**